일어설 때 어지러운 이유와 대처

앉거나 누웠다 일어설 때 혈압이 떨어질 수 있습니다. 검사 방법과 생활 속 대처를 알아봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

일어설 때 어지럽다면 혈압을 확인하세요

어지럼이나 넘어짐이 있다면 일어선 뒤 혈압을 재 보세요.

5–30%

지역사회 노인

기립성 저혈압을 겪는 비율

50%

요양시설 거주자

기립성 저혈압을 겪는 비율

2배

5년 사망률

기립성 저혈압이 없는 분과 비교

⚠ 왜 확인하나요?

넘어짐·골절·기절·심장혈관 문제와 관련이 있었습니다. 5년 사망률도 기립성 저혈압이 없는 분보다 약 2배였습니다.

그래서 확인합니다

65세 이상이거나 여러 약을 드신다면, 일어설 때 어지럼과 넘어짐을 진료 때 꼭 알려 주세요.

실천 · 일어설 때 핑 돌거나 넘어진 적이 있으면 혈압 검사를 요청하세요.

출처 · 마지막 장

언제 떨어지는지도 중요합니다

혈압이 떨어지는 시간에 따라 검사 방법이 달라집니다.

혈압이 바뀌는 때	시점	검사에서 보는 변화
일어선 뒤 몇 분 안에	3분 이내	위 혈압이 20 mmHg 이상 또는 아래 혈압이 10 mmHg 이상 떨어집니다. 누워 있을 때 혈압이 높다면 위 혈압 30 mmHg 이상을 기준으로 봅니다.
일어난 직후 잠깐	15초 이내	위 혈압 40 mmHg 이상 또는 아래 혈압 20 mmHg 이상 떨어졌다가 빠르게 회복합니다. 일어난 직후 재야 놓치지 않습니다.
조금 지난 뒤	3분 이후	늦게 혈압이 떨어질 수도 있어 증상에 따라 더 오래 잽니다. 신경 기능과 관련된 원인도 살펴봅니다.
맥박 또는 누운 혈압 변화	기립 · 누움	혈압이 안 떨어져도 일어서며 맥박이 분당 30회 이상 늘 수 있습니다. 누우면 위 혈압이 140 이상이면서 일어설 때 떨어지는 분도 있습니다.

실천 · 일어난 직후 잠깐만 어지러워도 진료 때 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

일어서면 몸속에서 무슨 일이 생길까요

일어설 때 다리로 쏠린 피를 몸이 보충하지 못하면 어지럽습니다.

정상 보상

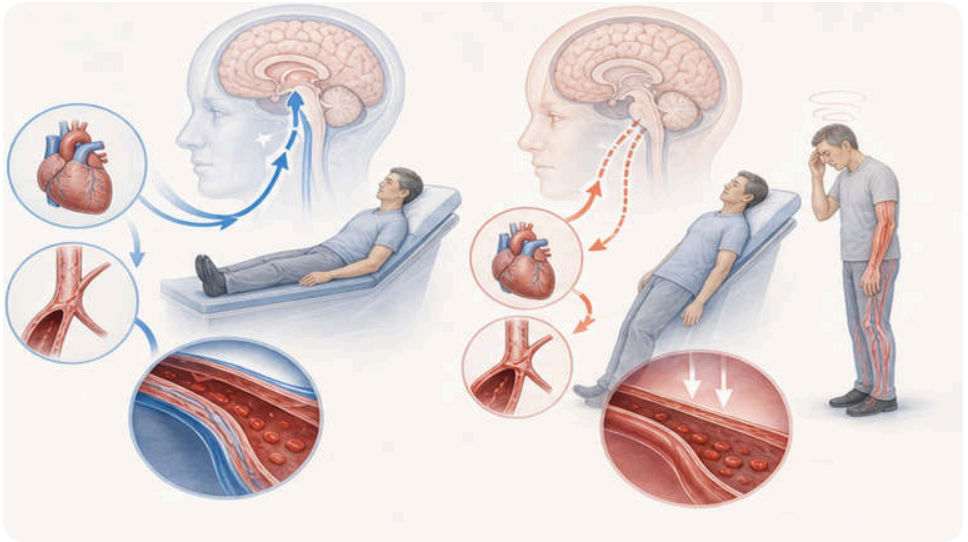
일어서면 피 600–800 ml가 다리로 내려갑니다. 몸은 곧바로 맥박을 +10–20 bpm 높이고 혈관을 좁혀 혈압을 지킵니다.

무너지는 두 갈래

신경이 혈압을 지키라는 신호를 제대로 보내지 못하거나, 탈수·약물·심장 문제로 몸이 반응하지 못할 수 있습니다.

신경성 단서

혈압이 떨어져도 맥박이 15 bpm 미만으로만 늘면 신경 반응에 문제가 있을 수 있습니다.



설명용 그림 · 일어서면 피가 다리로 내려가고, 몸이 맥박과 혈관을 조절해 혈압을 지킵니다.

실천 · 어지러울 때 맥박도 함께 재면 원인을 찾는 데 도움이 됩니다.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약과 탈수부터 살펴봅니다

원인에 따라 대처가 달라져 약 목록과 몸 상태를 함께 봅니다.

혈압 조절 신경의 문제

일어설 때 혈압을 지키는 신경 반응이 약한 경우

- 파킨슨병 · 다계통위축증
- 자율신경 기능 저하 · 루이소체 치매
- 당뇨병성 신경 문제 · 아밀로이드증

vs

약·탈수 등 다른 원인

신경 반응은 남아 있으나 몸속 피의 양이나 심장 기능이 부족한 경우

- 탈수·출혈·빈혈 · 심부전·심장판막병·심근경색 후
- 오래 누워 지낸 뒤 체력 저하
- 호르몬 이상 · 심한 감염 · 음주

실천 · 복용 중인 약과 최근 식사·물 섭취량을 함께 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

누워서, 일어서서 혈압을 잽니다

누워서 5분 쉰 뒤 일어서서 바로, 1분, 3분에 혈압과 맥박을 기록합니다.

1 누워서 5분 휴식
조용한 곳에서 기준 혈압·맥박수(대화·통화·식후 1시간 이내 측정은 피함).

2 기립 직후(15–30초)
초기형 검출용 — 빠르게 회복돼 놓치기 쉽다.

3 1분 후
흔한 유형이 잘 잡히는 구간.

4 3분 후 · 판정
수축기 20 이상 또는 이완기 10 mmHg 이상 하강이면 기립성 저혈압에 해당합니다.

맥박수 해석

맥박이 15 bpm 미만으로 늘면 신경 반응을, 혈압은 그대로인데 30 bpm 이상 늘면 맥박 문제를 살핍니다. 혈압만 떨어지면 탈수·약·심장 문제를 확인합니다.



설명용 그림 · 누워서 → 일어서서 — 같은 팔로 네 번 잽니다.

실천 · 검사 중 심하게 어지러우면 바로 앉아 넘어짐을 피하세요. 의식을 잃었거나 가슴 통증·숨참이 함께 있으면 응급실로 가세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약을 줄일지는 혈압 숫자와 증상을 함께 봅니다

90세 이상 노쇠 환자의 126/78 mmHg 증례

한 번의 수치로 중단하지 않습니다

126/78 mmHg라는 한 번의 수치만으로 중단하지 않습니다. 기립 1분·3분 혈압과 **수축기 ≥20 또는 이완기 ≥10 mmHg 감소**, 어지럼·낙상을 함께 봅니다.

감량을 검토하는 단서

가정 수축기혈압 **120 mmHg 미만의 반복**, 식사량 감소·탈수·급성 신손상 병력·복약 부담이 있으면 약 조정 필요성을 검토합니다.

약의 보호 목적 확인

심부전·알부민뇨·당뇨병성 콩팥병·뇌졸중·관상동맥질환처럼 약을 유지할 이유도 확인합니다. 혈압 수치와 동반질환을 함께 보고 정합니다.

스스로 끊기 전에 약의 적응증·증상·집에서 잰 혈압을 확인합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

복용 중인 약을 함께 확인하세요

약을 스스로 끊기 전에 처방 의사와 복용 시간·용량을 상의하세요.

① 혈압약

일부 혈압약과 소변을 늘리는 약은 일어설 때 혈압을 낮출 수 있습니다. 먹는 약을 모두 보여 주세요.

② 항우울제

삼환계(아미트립틸린·노르트립틸린), SSRI·SNRI(벤라팍신), 트라조돈 — α·항콜린 작용.

③ 항정신병제

클로르프로마진·리스페리돈·올란자핀·쿠에티아핀 — 2세대도 α1 차단으로 유발.

④ 도파민 작용제

레보도파·프라미펙솔·로피니롤 — 파킨슨병 자체와 약이 겹쳐 기여.

⑤ PDE-5 억제제 · 질산염

실데나필·타다라필 + 질산염 병용은 절대 금기. 단독도 위험↑.

⑥ 마약성 진통제 · 기타

트라마돌·모르핀, 1세대 항히스타민, 근이완제, 알코올 — 다약제에서 누적.



실행 · 먼저 복용 시간 조정(기립 위험 시간대 피하기) → 감량 또는 기립성 저혈압에 부담이 적은 약으로 교체. **임의 중단 금지** — 원질환 악화 위험.

실천 · 약 봉투나 처방전 사진을 진료실에 가져오세요. 임의로 끊지 마세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약을 조정한 뒤에도 계획대로 혈압을 확인합니다

건강한 중년과 노쇠 노인의 재시작 기준을 구분합니다

조정 뒤 2주·4주·월별 추적

감량·중단 뒤 **2주, 4주, 이후 월 1회** 간격으로 혈압·기립 증상·낙상을 확인합니다. 가정혈압은 측정값을 모두 기록합니다.

중년 증례의 기준

건강한 중년의 중단 증례에서는 가정혈압 평균이 **135/85 mmHg 이상**으로 오르면 의료진이 약을 다시 시작할지 검토합니다. 이를 모든 노쇠 노인에게 그대로 적용하지 않습니다.

노쇠 노인은 개별화

노쇠한 어르신은 혈압뿐 아니라 **어지럼·낙상·동반질환**을 함께 살펴 의료진이 치료 시작 시점을 정합니다.

재시작 기준과 다음 평가 날짜를 처방 의료진과 미리 정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

위 혈압이 높고 아래 혈압이 낮다면

70세 이상 160/60 mmHg일 때 의료진과 정하는 조정 원칙

조정 전에 확인할 것

가정·24시간 활동혈압과 기립혈압을 확인하고 **대동맥판역류·빈혈** 등 넓은 맥압의 원인도 살핍니다. 아래 혈압만 보고 위 혈압 조절을 포기하지 않습니다.

낮은 용량부터 천천히

약의 시작 용량과 조정 간격, 목표 혈압은 **의료진이 몸 상태에 맞춰** 정합니다. 어지럼과 일상생활의 변화를 기록해 다음 진료에 가져옵니다.

더 낮추지 않을 조건

이완기혈압 **60 mmHg 미만** 또는 어지럼·협심증·기립성 저혈압이 생기면 의료진이 추가 감량 여부를 다시 판단합니다. 증상과 혈류 공급을 함께 봅니다.

혈압 수치와 증상을 함께 살펴 개인 목표를 의료진과 정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

집에서 실천할 여섯 가지

수분·식사·압박·잠자리와 움직임을 함께 조절합니다.

① 수분 + 염분

하루 물 2 L 이상, 소금 6–10 g을 고려합니다. 심부전·콩팥병이 있으면 스스로 늘리지 말고 담당 의사와 먼저 정하세요.

② 식사 직전 찬물

식사 직전 찬물 240–480 ml를 마시면 식후 혈압 저하를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

③ 압박 스타킹

허리까지 오는 30–40 mmHg 권장. 무릎 길이는 효과 제한적. 아침 기상 전 누운 채 착용.

④ 침대 머리 올리기

침대 머리를 10–20° 올리면 밤에 누웠을 때 높은 혈압과 아침 어지럼을 함께 줄이는 데 도움이 됩니다.

⑤ 다리에 힘을 주는 동작

다리 꼬기·발끝 들기·발 펌프·쪼그려 앉기 — 기립 직전·도중에 혈압을 5–15 mmHg 올린다.

⑥ 피할 것

갑자기 일어서기·뜨거운 샤워·사우나·과식·알코올·더운 환경·장시간 부동·배변 때 강한 힘주기.

실천 · 심부전·콩팥병이 있으면 물·소금 양을 늘리기 전에 꼭 상의하세요.

출처 · 마지막 장

생활 조절 뒤에도 어지러우면

생활 조절과 약 확인 뒤에도 증상이 있으면 치료약을 검토합니다.

의사가 검토할 약	어떻게 돕나요?	복용 중 확인할 점
플루드로코르티손	몸에 물과 소금을 붙잡아 혈압을 올립니다.	칼륨·혈압·부종을 확인합니다. 심부전이나 심한 콩팥병이 있으면 쓸 수 없습니다.
미도드린	혈관을 좁혀 서 있을 때 혈압을 올립니다.	누워 있을 때 혈압이 높아질 수 있어 처방된 복용 시각을 지키세요.
드록시도파	신경 문제로 혈압이 떨어지는 분에게 검토합니다.	국내에서 쓸 수 있는지는 진료실에서 확인합니다.



약 조정은 진료실에서 · 한 약으로 부족하면 의사가 두 약을 함께 쓰거나 다른 약을 검토할 수 있습니다. 누워 있을 때 혈압도 함께 봅니다.

실천 · 혈압을 올리는 약은 누웠을 때 혈압을 높일 수 있어 복용 시각을 지키세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

낮과 밤의 혈압을 함께 봅니다

서 있을 때 낮은 혈압과 누웠을 때 높은 혈압을 같이 기록해야 합니다.

① 취침 전 혈압 측정 필수

자기 전 누워서 잰 혈압을 기록하세요. 180/110 mmHg를 넘으면 진료실에 알려야 간 혈압 대처를 상의합니다.

② 침대 머리 10–20° 거상

침대 머리를 올리면 밤 혈압이 약 10–15 mmHg 낮아지고 아침 어지럼도 줄 수 있습니다.

③ 야간 수축기 200 이상 → 단기 단시간 작용 강압제

밤 혈압이 매우 높으면 의사가 짧게 작용하는 약을 처방할 수 있습니다. 원문에 든 예는 히드랄라진 25 mg 또는 캡토프릴 25 mg입니다. 스스로 복용하지 마세요.

④ 저녁 약 복용 시각 확인

미도드린은 보통 잠들기 최소 4시간 전에 마지막으로 먹습니다. 누워서 잰 혈압이 높으면 의사가 시각이나 용량을 조정할 수 있으니 스스로 바꾸지 마세요.

실천 · 자기 전 누운 혈압과 낮에 선 혈압을 적어 오세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

반복 어지럼·낙상은 노쇠도 함께 살핍니다

노쇠는 나이와 진단받은 질환의 수만으로 설명되지 않습니다

CFS로 먼저 선별

임상노쇠척도(**CFS 1~9점**)로 생활기능과 도움의 필요를 살핍니다. **CFS ≥5**이면 연령·질환과 별개로 다면 평가와 중재가 필요한 고위험군입니다.

CGA로 중재할 문제 찾기

노인포괄평가(**CGA**)는 질병·약뿐 아니라 인지·정서·영양·신체기능·사회적 돌봄을 확인합니다. **50개 인자**를 함께 평가하는 방법이 있습니다.

점수 다음은 행동 계획

CFS는 빠른 선별, CGA는 구체적인 중재 영역을 찾는 평가입니다. 모든 분에게 같은 검사를 반복하기보다 발견된 문제를 약·영양·운동·돌봄 계획으로 연결합니다.

혈압이 안정적이어도 생활기능과 영양·돌봄의 결핍은 남을 수 있습니다.

아산 28회 연수강좌 — 왜 이 환자는 계속 안 좋아질까? 개원의가 시작하는 노인 통합돌봄(백지연)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

낙상 평가에서는 일상생활과 돌봄도 묻습니다

노인포괄평가에서 혈압 외에 확인하는 영역입니다

질병·복용약

약마다 필요한 이유, 중복 처방, 뇌에 작용하는 약과 항콜린약 부담을 확인합니다. 실제 복용 시간과 낮 동안 졸린지도 봅니다.

인지·정서·생활기능

우울·인지기능과 식사·목욕 등 기본 일상생활(**ADL**), 장보기·약 챙기기 등 도구적 일상생활(**IADL**)을 확인합니다.

영양·보행·사회적 지원

식사량·저체중·영양불량, 걷는 능력·낙상·근감소증, 독거 여부와 이용 가능한 지원을 함께 확인합니다. 문제에 맞춰 중재합니다.

혈압 기록과 함께 최근 식사량·보행·생활의 변화를 알려 주세요.

아산 28회 연수강좌 — 왜 이 환자는 계속 안 좋아질까? 개원의가 시작하는 노인 통합돌봄(백지연)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

뇌에 작용하는 약은 종류와 복용 시간을 봅니다

여러 약이 겹칠 때는 의료진이 용량과 복용 시간을 조정합니다

CNS-active 약 3종 이상

뇌에 작용하는 약 **3종 이상**은 섬망·낙상 위험과 연결됩니다. 항콜린약·항경련제·항정신병약·벤조디아제핀·수면제·항우울제·오피오이드를 함께 봅니다.

약이 겹칠 때의 조정

졸림이나 어지럼을 일으킬 수 있는 약이 겹치면 **의료진이 용량과 복용 시간을 하나씩 조정**합니다. 모든 약을 한꺼번에 임의로 중단하지 않습니다.

불필요한 약과 영양도 검토

어지럼약·방광약·당뇨약도 함께 확인합니다. **영양 상태·체중 변화·치료 이득**을 보고 의료진이 약을 바꿀지 정하며, 모든 분에게 같은 변경을 적용하지 않습니다.

처방전·약봉투를 모두 가져와 한 번에 검토합니다.

아산 28회 연수강좌 — 왜 이 환자는 계속 안 좋아질까? 개원의가 시작하는 노인 통합돌봄(백지연)

약·영양·돌봄을 함께 조정한 4주 경과

한 환자의 치료 경과이며, 어느 약 하나의 효과로 해석하지 않습니다

노쇠·체중의 변화

4주 후 **CFS 6→5점**, 체중 **49→51 kg**이었습니다. 어지럼이 완화되고 의식이 또렷해졌으며 식사량·활동량이 늘었습니다.

기능·영양의 변화

신체기능검사 **SPPB 6→9점**, 영양평가 **MNA 18→24점**이었습니다. 혈압만 확인하지 않고 기능·영양을 함께 추적했습니다.

여러 영역을 함께 돌본 결과

약 조정에 더해 **경구영양보충·장기요양 연계**를 함께 시행했습니다. 다음 진료에서도 약·식사·활동·도움받는 환경의 변화를 같이 봅니다.

증례의 변화는 모든 환자에게 같은 결과를 보장하는 수치가 아닙니다.

아산 28회 연수강좌 — 왜 이 환자는 계속 안 좋아질까? 개원의가 시작하는 노인 통합돌봄(백지연)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진료 이후까지 이어지는 돌봄을 계획합니다

약 조정과 영양·기능·사회적 지원을 한 계획으로 연결합니다

CFS 5·6: 돌봄 필요 살피기

생활에 도움이 필요한지 확인하고 **장기요양·지역사회 통합돌봄** 자원을 연결합니다. 점수만으로 장기요양 등급이 자동 결정되는 것은 아닙니다.

심한 노쇠: 앞으로의 돌봄 논의

CFS **7·8·9**의 매우 심한 노쇠·말기 질환 단계에서는 환자의 목표와 **사전돌봄계획**을 함께 검토합니다.

의료·요양·복지 연결

방문진료·복약지도·운동·영양·방문요양·생활지원 등 필요한 도움을 연결합니다. 환자의 상태가 변하면 계획도 다시 조정합니다.

의료진이 변화를 발견하고 지역 돌봄과 연결하는 출발점이 됩니다.

아산 28회 연수강좌 — 왜 이 환자는 계속 안 좋아질까? 개원의가 시작하는 노인 통합돌봄(백지연)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

어지럼이 생긴 분의 검사 예

실제 처방은 개인 상태에 따라 달라지는 설명용 사례입니다.

1

환자 · 약물

78세 여성

6개월 전부터 일어설 때 어지럽고 한 번 넘어졌습니다. 소변을 늘리는 혈압약 25 mg, 다른 혈압약 5 mg, 우울증약 50 mg을 먹습니다. 당뇨·콩팥병은 없습니다.

2

누웠다 일어서서 재는 혈압 검사

4시점

기준 145/85·72 → 직후 130/75·76 → 1분 110/70·78 → 3분 100/65·80. 수축기 −45 mmHg, 맥박수 +8(반응 부족).

3

진단

신경성 + 약물 기여

일어선 뒤 수축기 혈압이 45 mmHg 내려갔고 맥박은 8 bpm만 올랐습니다. 신경 반응과 복용약 두 가지를 함께 살핍니다.

4

의사와 조정

2주 뒤 재평가

이 사례에서는 의사가 소변을 늘리는 약을 중단하고 다른 혈압약의 복용 시간을 바꾼 뒤 2주 후 다시 봅니다. 계속 어지러우면 혈압을 올리는 약 0.1 mg을 검토합니다.

실천 · 사례의 약 조정은 따라 하지 말고 본인 처방 의사와 상의하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘부터 기억할 여섯 가지

증상 기록과 약 목록을 진료실에 가져오세요.

1. **일어설 때 어지러우면 혈압 검사**
   누웠다 일어서며 혈압을 재는 검사는 몇 분이면 됩니다.
2. **복용약 확인이 첫걸음**
   복용약을 확인하는 것부터 시작합니다. 약 봉투를 가져오세요.
3. **생활에서 먼저 조절**
   물·소금, 압박 스타킹, 침대 머리 올리기와 피할 상황을 의사와 함께 정합니다.
4. **계속 어지러우면**
   의사가 혈압을 올리는 약을 검토할 수 있습니다. 스스로 약을 바꾸지 마세요.
5. **누웠을 때 혈압도 기록**
   낮과 밤의 혈압을 함께 보고 약 시각을 조정합니다.
6. **호전 없으면 다시 상담**
   필요하면 신경과 등 관련 진료과와 함께 원인을 찾습니다.

SCAN TO REVISIT

슬라이드 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다

Moloney D 외, JAMA Intern Med 2026, doi:10.1001/jamainternmed.2026.0284 · AAS/EFAS 2011 · Beers Criteria 2023